Prise en charge non médicamenteuse de la douleur

Support de travail établi à partir des documents transmis. Le rattachement Moodle a été vérifié sur la liste des ressources ; les fichiers Moodle non récupérés et les commentaires audio ne sont pas déclarés intégralement contrôlés.

UE B.3 | PRATIQUES ET INTERVENTIONS INFIRMIÈRES

Prise en charge non médicamenteuse de la douleur

Synthèse détaillée • cours TNM VF (45 min 21 s) • version de révision du 9 octobre 2026

À retenir : les techniques non médicamenteuses COMPLÈTENT les antalgiques. On choisit selon la personne, la douleur, les préférences et les contre-indications, puis on RÉÉVALUE.

Objectifs à maîtriser

Définir les techniques non médicamenteuses (TNM) et leur place dans une prise en chargemultimodale.

Expliquer pourquoi la douleur est multidimensionnelle et peut être modulée par le système nerveux.

Identifier les techniques accessibles pendant les soins et celles qui exigent matériel,prescription ou formation.

Choisir, surveiller et évaluer une intervention adaptée à une situation clinique.

1. Les fondements : ce qu’est la douleur

Définition de travail : expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, propre à la personne. L’intensité exprimée par le patient doit être prise au sérieux : l’absence de lésion visible ne prouve pas l’absence de douleur.

Sensorielle-discriminative

Manifestations et implications : Siège, type (brûlure, picotement, élancement), intensité, durée.

Affective / émotionnelle

Manifestations et implications : Peur, anxiété, colère, tristesse : peuvent majorer la souffrance.

Cognitive

Manifestations et implications : Interprétation, croyances, anticipations : « cette douleur signifie-t-elle une aggravation ? »

Comportementale

Manifestations et implications : Grimaces, pleurs, agitation, immobilité, position antalgique, repli.

Le lien clinique : l’installation agit sur le confort ; la distraction agit sur l’attention ; respiration et communication sur l’anxiété ; toucher sur la perception et la sécurité.

2. Comment le message douloureux est modulé ?

Départ : activation des nocicepteurs (récepteurs d'un stimulus potentiellement dommageable), transmission vers la moelle épinière puis les centres cérébraux.

Gate control / théorie du portillon : une stimulation tactile non douloureuse peut, dans certaines situations, réduire la transmission de messages nociceptifs au niveau médullaire.

Modulation descendante : le cerveau peut atténuer ou amplifier la perception selon l'attention, les émotions, les expériences, le contexte et les systèmes d'analgésie endogène (dont les endorphines).

Conséquence : deux personnes peuvent vivre différemment une même stimulation ; une même personne peut aussi ressentir différemment la douleur selon le contexte.

3. Techniques simples intégrables aux soins quotidiens

Installation et environnement

Principe / exemples : Repositionner, soutenir avec coussins, limiter points d'appui, ajuster lumière/bruit, préserver repos et intimité.

Précautions et surveillance : Demander les préférences ; surveiller confort, peau, tolérance à la mobilisation et efficacité.

Chaleur

Principe / exemples : Détente musculaire et vasodilatation locale. Peut aider certaines tensions ou contractures.

Précautions et surveillance : Ne pas appliquer directement une source brûlante ; protéger la peau, limiter la durée, tenir compte des troubles sensitifs, circulatoires ou cutanés.

Froid

Principe / exemples : Vasoconstriction, ralentissement local de la conduction nerveuse ; peut aider certaines douleurs/inflammations et certains œdèmes.

Précautions et surveillance : Interposer une protection ; durée adaptée ; vigilance particulière pour troubles de sensibilité, circulation, fragilité cutanée.

Distraction

Principe / exemples : Musique, conversation, jeu, photos, film, projection lumineuse : détourner l'attention, notamment durant un soin douloureux.

Précautions et surveillance : Adapter à l'âge, aux goûts, aux capacités ; ne pas nier la douleur ou se substituer à l'analgésie nécessaire.

Respiration lente

Principe / exemples : Ex. rythme confortable proche de 6 cycles/minute (5 s inspiration, 5 s expiration), pour apaiser la réponse au stress.

Précautions et surveillance : Ne jamais imposer un rythme ; adapter en cas de gêne respiratoire, étourdissement ou mauvaise tolérance.

Communication apaisante

Principe / exemples : Voix calme, explication claire, focalisation sur la respiration ou un souvenir agréable ; éviter les formulations inutilement anxiogènes.

Précautions et surveillance : Information honnête, consentement ; ne jamais promettre une absence de douleur.

Toucher-massage

Principe / exemples : Contact doux et progressif, bercement, pressions légères, relaxinésie ; aide possible via stimulation tactile, détente et relation.

Précautions et surveillance : Accord explicite ; respecter les refus et vécus ; ne pas masser lésion, hématome, zone inflammatoire ou suspicion de thrombose.

Exemple de soin : avant une prise de sang, expliquer le geste et proposer une conversation ou une respiration calme. Après le soin, demander si cela a réellement aidé.

4. Réalité virtuelle et hypnose : distinguer les pratiques

Réalité virtuelle (RV) : immersion visuelle et sonore pour mobiliser l'attention ; utilisée dans certains soins anxiogènes/douloureux. Matériel, accompagnement et adaptation nécessaires.

Principes de communication inspirés de l'hypnose : voix posée, focalisation, images agréables ; ces gestes relationnels ne constituent pas à eux seuls une séance d'hypnose.

Hypnose thérapeutique : exige une formation spécifique ; le cours cite la transformation mentale d'une image représentant la douleur comme exemple.

Attention : une approche non médicamenteuse ne signifie ni absence de risque ni efficacité certaine chez tout le monde.

5. Approches nécessitant des compétences ou moyens particuliers

TENS

À comprendre : Neurostimulation électrique transcutanée : courant de faible intensité via électrodes cutanées. Deux approches évoquées : stimulation conventionnelle (portillon) et stimulation favorisant l'analgésie endogène.

Place et limites : Certaines douleurs chroniques, notamment neuropathiques selon indication. Dispositif médical ; essai, prescription et éducation selon cadre applicable. Stimulation perceptible mais non douloureuse. Surveillance cutanée.

Activité physique adaptée (APA)

À comprendre : Remise en mouvement progressive, entretien force/mobilité, amélioration possible humeur, sommeil et anxiété ; évite le cercle douleur → inactivité → déconditionnement → douleur.

Place et limites : Programme individualisé selon pathologie, capacités et risques ; encadré par professionnels compétents. Le rythme donné dans le cours est un exemple, pas une règle universelle.

Photobiomodulat ion (PBM)

À comprendre : Lumière rouge / proche infrarouge par LED ou laser ; le cours expose des effets biologiques potentiels sur les tissus.

Place et limites : Technique spécifique : matériel, formation, indication et niveau de preuve à considérer ; ne pas conclure à une efficacité générale.

Autres méthodes

À comprendre : Acupuncture, auriculothérapie, sophrologie, aromathérapie, musicothérapie, entre autres.

Place et limites : Niveau de preuve et risques variables ; avis adapté, formation et consentement selon la méthode.

Zoom TENS - surveillance IDE : vérifier cadre de prescription/protocole, localisation et intégrité cutanées, indications et contre-indications propres au dispositif ; mesurer la douleur avant/après ; noter la tolérance, les éventuelles rougeurs, le bénéfice et l'apprentissage de l'utilisation.

Sécurité TENS : signaler impérativement tout dispositif électronique implanté (pacemaker, défibrillateur). La grossesse et l'épilepsie nécessitent une évaluation spécifique ; suivre la notice, la prescription et les protocoles, sans déduire des contre-indications absolues identiques pour tous les appareils.

6. Ce que doit savoir faire l'infirmier / infirmière

La prise en charge de la douleur est une responsabilité professionnelle. Le Code de la santé publique, art. R4312-19, impose de s'efforcer de soulager les souffrances par des moyens appropriés et de dispenser des soins antidouleur dans le cadre des compétences, prescriptions et protocoles.

1. ÉVALUER

Actions concrètes au lit du patient : Où ? Depuis quand ? Quelle intensité (0–10 si l'échelle numérique convient) ? Type, facteurs aggravants/ soulageants , retentissement, signes associés ?

2. IDENTIFIER

Actions concrètes au lit du patient : Demander au patient ce qui le soulage habituellement, ses choix, ses capacités, ses craintes et ses contre-indications.

3. CHOISIR

Actions concrètes au lit du patient : Proposer une ou plusieurs interventions réalisables en sécurité et dans les compétences autorisées ; obtenir l'accord.

4. ASSOCIER

Actions concrètes au lit du patient : Ne pas opposer l'antalgique prescrit à l'installation, la distraction, le toucher adapté ou la respiration.

5. RÉÉVALUER

Actions concrètes au lit du patient : Comparer douleur avant/après avec la même méthode ; vérifier la tolérance et adapter ou arrêter si inefficace.

6. TRACER / ALERTER

Actions concrètes au lit du patient : Noter technique, contexte, efficacité, préférences, effets indésirables et transmissions ; alerter si douleur inhabituelle, aggravation ou soulagement insuffisant.

7. Situations cliniques types : raisonner, ne pas appliquer une recette

Prise de sang anxiogène

Pistes à discuter avec le patient : Information rassurante sans mensonge + respiration choisie + distraction ; antalgie appropriée selon le soin.

Patient alité avec lombalgies

Pistes à discuter avec le patient : Points d'appui, repositionnement, coussin, réduction des stimulations ; réévaluation.

Douleur chronique et évitement du mouvement

Pistes à discuter avec le patient : Prise en charge globale ; programme d'activité adaptée encadré selon indication.

Douleur neuropathique persistante

Pistes à discuter avec le patient : Évaluation, prise en charge médicamenteuse si indiquée, éventuelle orientation douleur/TENS selon protocole.

Patient refusant le toucher

Pistes à discuter avec le patient : Respect du refus ; explorer environnement, respiration, distraction ou autres options acceptées.

8. Lexique indispensable pour les partiels

Antalgique / analgésie

Définition simple : Traitement ou mécanisme qui réduit la douleur / diminution de la douleur.

Nociception / nocicepteur

Définition simple : Détection et transmission d'un stimulus potentiellement nocif / récepteur impliqué.

Multidimensionnel

Définition simple : Qui implique plusieurs dimensions : sensorielle, émotionnelle, cognitive et comportementale.

Multimodal

Définition simple : Association de différentes modalités de prise en charge complémentaires.

Gate control

Définition simple : Modulation « portillon » de la transmission douloureuse au niveau médullaire.

Endorphines

Définition simple : Peptides opioïdes produits par l'organisme, participant notamment à l'analgésie endogène.

Vasodilatation / vasoconstriction

Définition simple : Augmentation / diminution du diamètre des vaisseaux sanguins.

Douleur neuropathique

Définition simple : Douleur causée par une lésion ou une maladie du système nerveux somatosensoriel.

Définition simple : Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation : stimulation électrique nerveuse transcutanée.

APA / PBM

Définition simple : Activité physique adaptée / photobiomodulation .

Relaxinésie

Définition simple : Mobilisations passives lentes visant un relâchement corporel ; nécessite adaptation/compétence.

Réévaluation

Définition simple : Nouvelle mesure de l'état douloureux après une intervention, comparée à l'état initial.

9. Les 14 notions à connaître par cœur

Les TNM complètent l'analgésie médicamenteuse, sans la remplacer.

La douleur est subjective et multidimensionnelle.

Les quatre composantes sont sensorielle, affective, cognitive et comportementale.

Le signal nociceptif est modulé à la moelle et au cerveau.

Gate control : une stimulation tactile peut réduire la transmission douloureuse.

L'environnement, l'installation et la relation soignante sont de véritables interventions.

Le chaud détend ; le froid peut ralentir la conduction et réduire certains phénomènes inflammatoires.

Chaud/froid : protéger la peau, limiter et surveiller la durée et la tolérance.

La distraction modifie le traitement attentionnel de la douleur, pas nécessairement le stimulus.

Respiration et communication apaisante peuvent réduire l'anxiété associée.

Le toucher est consenti, adapté et évalué ; ne pas masser une zone à risque.

TENS, hypnose thérapeutique, APA, PBM exigent des indications ou compétences adaptées.

Efficacité et sécurité des techniques doivent être appréciées d'après les preuves et le patient.

Démarche IDE : évaluer → identifier → choisir → associer → réévaluer → tracer/alerter.

Phrase-clé du cours : « Il n’existe pas une bonne technique, mais des techniques adaptées à chaque patient et à chaque situation. »

10. Mini auto-évaluation

Pourquoi une technique de distraction peut-elle atténuer une douleur sans supprimer lestimulus nociceptif ?

Cite deux précautions avant d’appliquer du chaud ou du froid.

Quelle est la différence entre communication apaisante et hypnose thérapeutique ?

Quelles informations noter avant et après une intervention non médicamenteuse ?

Pourquoi « naturel » ne veut-il pas dire « sans risque » ?

Fiabilité de cette fiche et sources

Source principale : « TNM VF.txt », transcription automatique horodatée, 45 min 21 s. Les termes manifestement déformés ont été reformulés lorsque le sens était évident. Le passage vers 26:14–27:37 contient une répétition artificielle : la présentation initiale du TENS est probablement incomplète. Des noms propres et plusieurs exemples vidéo restent incertains. Cette fiche n’est donc pas une retranscription littérale validée.

Vérifications réglementaires et scientifiques :

Arrêté du 20 février 2026 relatif au diplôme d’État d’infirmier, annexe III : référentiel de formation(Légifrance).

Code de la santé publique, art. R4311-2 et R4312-19, dispositions en vigueur en 2026 (Légifrance).

HAS : « Prise en charge du patient présentant une lombalgie commune » (activité physique).

Arrêté du 17 octobre 2025 : prise en charge des dispositifs de neurostimulation TENS (Légifrance).

Références : legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053570499/ · legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072665/LEGISCTA000006161001/ · has-sante.fr/jcms/c_2961499/ · legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000052404087

Liens à retenir

Une expérience globale

La douleur associe dimensions sensorielle, émotionnelle, cognitive et comportementale. Attention, vécu et contexte peuvent modifier l’expérience. Une approche non médicamenteuse complète, selon les besoins, les autres traitements.

Installation et relation

Rechercher une position confortable, limiter les appuis douloureux, expliquer les gestes, respecter l’intimité et obtenir l’accord. Une présence calme et une communication adaptée peuvent diminuer l’anxiété liée au soin.

Distraction et respiration

Proposer musique, conversation, jeu, image ou activité choisie. Une respiration lente et confortable peut être utilisée sans imposer un rythme pénible. Adapter à la personne, à ses capacités et au soin ; mesurer l’effet réellement obtenu.

Chaud froid et toucher

Choisir selon l’indication, la peau, la sensibilité et la circulation. Protéger la peau et contrôler la tolérance. Le toucher ou massage nécessite l’accord et ne doit pas être appliqué sur une zone contre-indiquée.

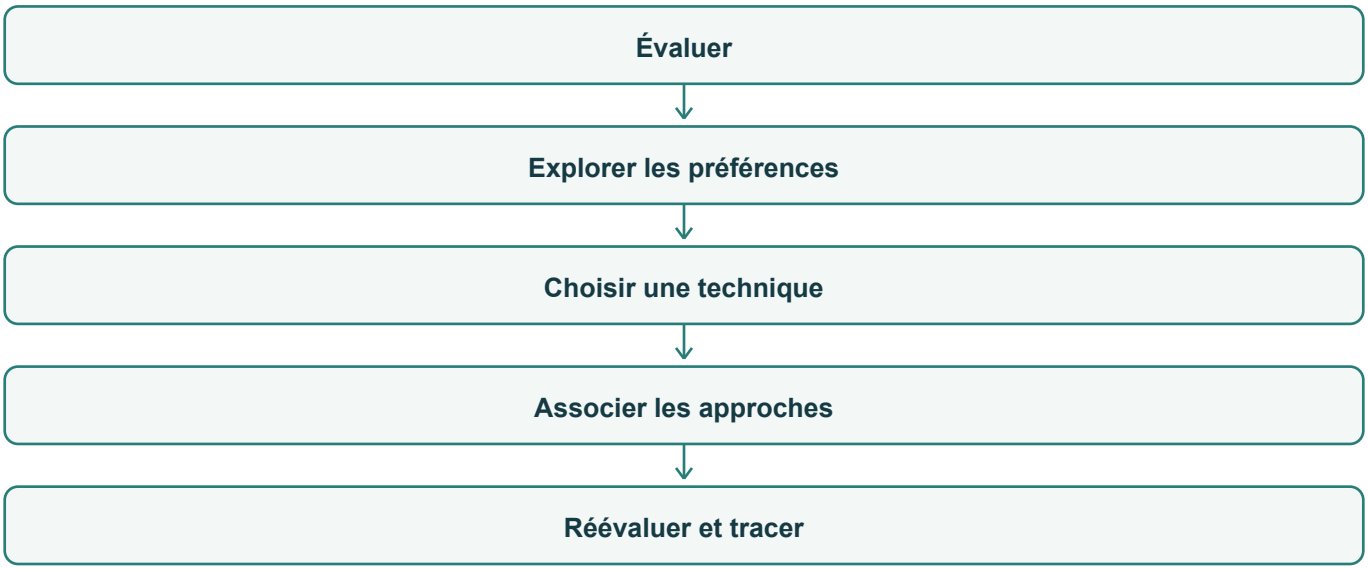
Techniques spécifiques

TENS, hypnose, réalité virtuelle ou activité physique adaptée nécessitent une indication, un matériel et des compétences appropriés. Les précautions du dispositif et de la situation priment sur une liste générale présentée comme universelle.

Suivi

Noter la douleur avant et après, le contexte, la technique, la durée et la tolérance. Une absence d’amélioration conduit à réexaminer la situation et à transmettre. Aucun visionnage des capsules du 7 et du 8 octobre n’est attesté par la présence de cette synthèse.

Schéma et vérification des acquis



Questions et réponses

Une technique convient-elle à tous ? Non.

Faut-il réévaluer ? Oui, avec un outil et un contexte adaptés.

Un support écrit prouve-t-il le visionnage ? Non.

Sources et portée

UE B3 PRISE EN CHARGE NON MEDICAMENTEUSE FINALE.docx

Rattachement au thème établi à partir des documents transmis ; ressource exacte ou capsule non vérifiée.